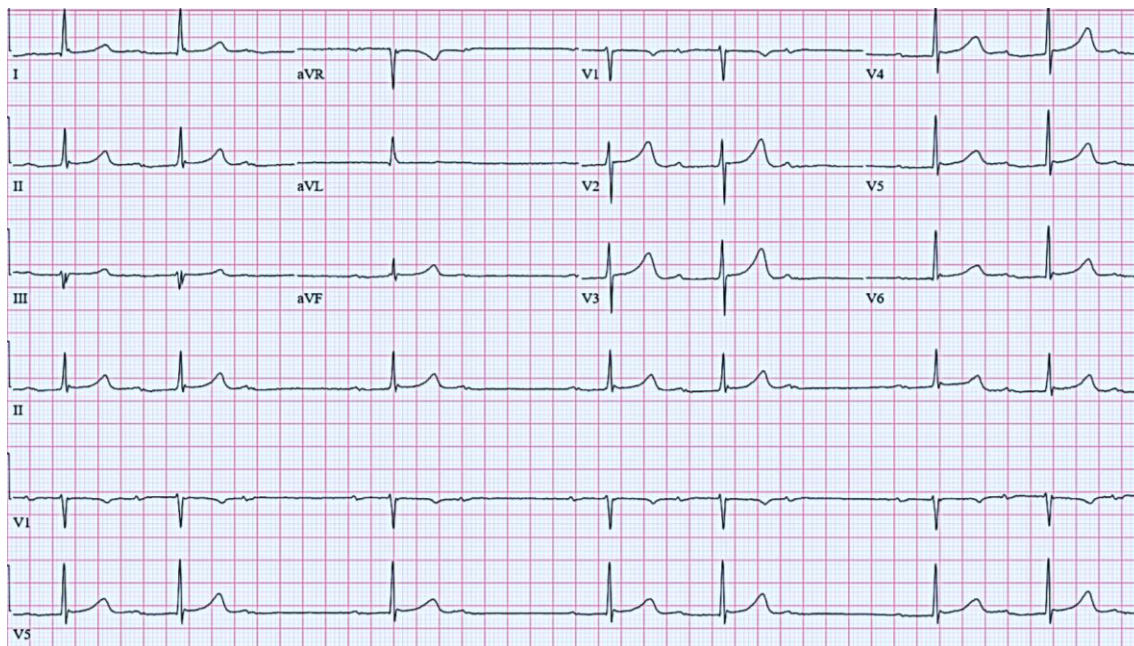


2^ο Βαθμού Κολποκοιλιακός Αποκλεισμός - Mobitz I (ή Luciani - Wenckebach AV block)

- Η αρρυθμία αφορά στην προοδευτική αύξηση του διαστήματος PR μέχρι εκπτώσεως ενός επάρματος QRS μετά από ένα μη επαγόμενο κολπικό έπαρμα P. Παρ' όλα αυτά, τα διαστήματα PP παραμένουν σταθερά εκτός εάν συνυπάρχει κολπική αρρυθμία.
- Οφείλεται σε αποκλεισμό - διακοπή της αγωγής του ηλεκτρικού ερεθίσματος στο ύψος του κ-K κόμβου, συχνά παροδικά, ενώ σπανίως οδηγεί σε πλήρη κ-K αποκλεισμό.
- Επειδή ο κ-K αυτός αποκλεισμός, τύπου Wenckebach, εντοπίζεται κοντά στο σύστημα His-Purkinje, το σύμπλεγμα QRS εμφανίζεται κατά κανόνα φυσιολογικό.



- Γενικά, δεν προκαλεί κλινικά συμπτώματα από αιμοδυναμική επιβάρυνση.
- Εμφανίζεται συνήθως σε κατώτερο OEM, τοξικό δακτυλιδισμό, υπερκαλιαιμία, κατόπιν καρδιοχειρουργικών επεμβάσεων, μυοκαρδίτιδα (v. Lyme), παρασυμπαθητικοτονία κ.ά.



Θεραπευτική παρέμβαση

1. Δεν απαιτείται ιδιαίτερη αντιμετώπιση για τους ασυμπτωματικούς ασθενείς· εκτός εάν ο αργός κοιλιακός ρυθμός (βραδυκαρδία) προκαλεί υπόταση κι άλλα συνοδά συμπτώματα λόγω της υποάρδευσης ιστών και οργάνων, οπότε δρούμε αναλόγως. Σε περιπτώσεις που το επεισόδιο αρρυθμίας οφείλεται σε φάρμακα (*β-αναστολείς, διγοξίνη*) διακόπτουμε τη χορήγηση των φαρμάκων και συστήνουμε άμεσα καρδιολογική εκτίμηση από ειδικό.
2. Χορηγούμε 0,5-1,0 mg **Ατροπίνη**, iv bolus, που επαναλαμβάνεται κάθε 3-5 λεπτά, μέχρι τη μέγιστη δόση των 3 mg (δηλ. μέγιστη δόση: 3 amp. Atropine 1 mg) ενδοφλεβίως.
3. Σε περιπτώσεις κατώτερου OEM, μεριμνούμε αρχικώς για την αντιμετώπιση του OEM και την αποκατάσταση του ενδαγγειακού όγκου [βλ. σελ. 93-95 – OEM]. Τοποθετούμε 3way φλεβική γραμμή και χορηγούμε ορό 500-1000 ml NaCl 0,9% αναλόγως της ΑΠ. Η πιθανή εμμένουσα υπόταση διορθώνεται με ινότροπα (*Ντοπαμίνη ή Δοβουταμίνη*).
4. Εξωτερική διαδερμική βηματοδότηση – *αν και σπανίως απαιτείται επί Mobitz I* – μπορεί να εφαρμοστεί σε βαρείς συμπτωματικούς ασθενείς, μέχρι την άφιξη στο νοσοκομείο.